

胃肠功能紊乱中药治疗

于小惠

(金华同济泌尿外科医院内科, 浙江 金华 321000)

[摘要] 随着现代社会的发展, 人们的物质生活条件得到了极大的改善, 但是工作、生活、学习中的巨大压力却使得一些人陷入了亚健康状态, 即没有明显的疾病症状, 但却身体、精神状态却难以很好地支持工作、生活、学习的良性运转, 其中胃肠功能紊乱就是一种常见的症状。近几年中药在治疗、保健等方面的功效逐渐受到人们的重视, 因此, 笔者结合胃肠功能紊乱, 根据相关案例分析, 对中药治疗方法进行探究, 以期对中医学在应对亚健康问题中提供参考依据。

[关键词] 胃肠功能紊乱; 中药治疗; 治疗原则; 临床研究

[中图分类号] R28 **[文献标识码]** A

DOI:10.19738/j.cnki.psy.2019.17.206

植物神经功能紊乱不是一种器质性疾病, 它是常常被人们提及的亚健康, 也可以叫作功能性紊乱。胃肠功能紊乱属植物神经功能紊乱一个类型。表现为没有食欲, 进食无味, 喉部梗噎, 咽喉不利, 上腹胀, 肠鸣, 腹痛, 腹泻, 便秘等症状。患者常常以自觉症状为主, 多次检查, 结果都比较正常, 虽然进行治疗, 往往疗效不尽如人意, 其实这些症状都与植物神经有着密切关系。在现代临床医学中, 西医占据主导地位, 针对疾病, 医生通常利用医疗器械、设备辨别病情、确定位置, 并通过给药增强机体与疾病的对抗能力, 这在急病中有着显著的治疗效果。但是胃肠功能紊乱在临床表现中常常处于一种“不病而病”的状态, 患者症状时断时续, 并且在临床检查中缺乏切实具体的依据, 这时采用中医治疗相较于西医的方案则会起到良好的效果。

1 胃肠功能紊乱中药治疗概述

《丹溪心法·六郁》中有言: “郁者结聚而不得发越也, 当升者不得升, 当降者不得降, 当化者不得化, 此为传化失常, 六郁之病见矣。”, 由此可见, 根据中医观点, 胃肠功能紊乱与“气”的升降失常密切相关; 此外, 古代中医学家张仲景在阐述伤寒杂病中, 也提出了“保胃气”的观点, 针对患者胃肠功能失调等症状, 秉承“有胃气则生, 无胃气则死”的原则, 进行调和治疗。在现代医学研究中, 医学专家从科学角度对胃肠功能紊乱的发病机制进行研究, 相关文献中表明胃肠是激发炎症反应的主要根据地, 是引发脓毒症和多器官功能障碍的中心, 而这一中医学研究中胃肠失调则引发其他器官功能运行障碍的观点不谋而合。

近几年中医在慢性疾病治疗中的显著效果, 使得中药、针灸、按摩等又重新回到了人们的视野, 针对胃肠功能紊乱这一常见病症, 中药在治疗中主要体现以下两点原则: 第一, 辨别病位。胃肠功能紊乱在中医学中被划分为脾胃失调, 即胃肠症状与脾功能的调节出现失常有关, 因此, 中医通常会基于脾主运化的功能, 为患者开出补脾益气的升阳中药方, 以帮助患者调动脾功能, 以运化胃气迟滞、升降失常、气机逆乱的问题, 该治疗方案主要适用于出现饱腹、暖气、呕吐的患者, 即通过理气通降实现胃肠功能复原; 此外, 针对腹痛、肠鸣、腹泻的患者, 则注重其中焦气机运行平衡, 并通过升阳益气实现胃肠协调。由此可见, 在中药治疗中, 医生需要根据患者的主要症状确定发病位置, 并结合气机的运行状态进行针对性给药。第二, 理解病机。根据中医理论, 胃肠功能紊乱的病机并不仅限于胃肠, 而是七情郁结、思虑过度的综合表现, 因此, 根据患者胃肠功能紊乱的具体表现, 找出病机才是中医对症下药的关键。七情郁结、思虑过度会造成气血失调、气机紊乱、肝木克土的问题, 因

此肝气失调则是胃肠功能紊乱的病机。基于此, 中医在临床治疗中, 应注重疏肝理气, 利用柴胡疏肝散、加味香苏饮等调节气机, 梳理肝气; 针对长期郁结的情况, 则对于损伤胃阴的药物适当减量, 避免胃气损伤, 以实现柔肝、养肝的效果。

2 胃肠功能紊乱中药治疗的案例分析

某女, 53岁, 黑龙江人, 诉咽部不适, 有物梗塞感, 吐之不出, 咽之不下, 随情志变化而加重减轻, 舌苔白腻, 脉弦滑。TSH6.07 uIU/mL ATG698 IU/mL TPO799 IU/mL外院考虑桥本氏病, 中医属梅核气。《金匱要略》: “妇人咽中如有炙脔, 半夏厚朴汤主之”。此病得于七情郁气, 凝涎而生, 故用半夏、厚朴、生姜, 辛以散结, 苦以降逆; 茯苓佐半夏, 以利饮行涎; 苏叶芳香, 以宣通郁气; 黄芩苦寒, 善清少阳相火、海藻咸寒润下之品, 软坚行水, 此做引经之药。病者岁大, 加杜仲、桑寄生补益肝肾调治善后而愈。

某男, 37岁, 浙江东阳人, 诉胸中烦闷, 胃脘痞满, 时有腹痛, 反复发作, 失眠, 舌质红, 苔黄腻, 脉弦。胃肠镜检查未见明显异常, 血肝功能正常。此为痞满, 胃气不和, 湿浊中阻所致, 半夏泻心汤主之, 半夏、干姜之辛温开结散其寒, 黄连、黄芩之苦寒降泄除其热, 参、炙甘草、大枣之甘温益气补其虚; 重用浮小麦以养心安神; 本方特点虽舌红不忌姜夏, 虽舌淡不避芩连。寒热并用, 辛开苦降, 补泻并施, 邪去正复而愈。清叶天士亦以泻心法治中焦湿热, 并指出: “苦寒能驱热除湿, 辛通能开气宣浊”。

某男, 51岁, 浙江萧山人, 平素嗜食辛辣, 诉肠鸣, 腹痛, 腹泻, 便秘交替出现, 大便常规正常, 结肠、肛肠镜未见明显异常, 排除器质性病变。腹痛泄泻之证成因复杂, 治法亦多。本方所治, 是由脾虚肝旺, 土虚木乘, 脾受肝制, 升降失常而致。治痛泻要方主之。吴翰皋云: “泻责之脾, 痛责之肝, 肝责之实, 脾责之虚, 脾虚肝实, 故令痛泻。”方用白术燥湿健脾, 白芍养血泻肝, 陈皮理气醒脾, 防风散肝舒脾。四药相配, 可以补脾土而泻肝木, 调气机以止痛泻。若久泻者, 脾气益虚, 清阳陷下, 故加升麻以清阳而增止泻之功; 舌苔黄腻, 加黄连、煨木香以清热燥湿, 理气止泻; 便秘者加瓜蒌仁、火麻仁、肉苁蓉润肠通便。

综上所述, 胃肠功能紊乱在临床中经常呈现出“无形之病”的特点, 根据上述三个案例也可以看出, 患者均以情志所得, 气郁则升降不行, 运化失常, 湿聚痰生。无形之病生于气, 有形之病生于痰。借吴谦曰: “夫人以气为本, 气和则上下不失其度, 运行不停其机, 病从何生”。基于此, 采用中药加以调理, 达到祛邪扶正的效果, 自然药到病除。

参考文献

- [1] 黄捷平. 中药封包配合艾灸治疗胃肠功能紊乱40例[J]. 中国中医现代远程教育, 2016, 14(17): 78-80.
- [2] 王振华, 吕立生. 中药胃肠通治疗胃肠功能紊乱[J]. 新消化病学杂志, 1997, 35(7): 43-44.
- [3] 季玉峰, 王立春. 中药健脾益肠汤治疗胃肠功能紊乱的近期疗效观察[J]. 海军医学, 1996, 13(4): 369-370.